VS 慢性肾盂肾炎(内科考),与肾结核共性:慢性膀胱刺激症+双肾不对称缩小+肾盂肾盏变形

出诊断题,鉴别①看主诉-是否有结核病史　外科学 血管和泌外疾病

②膀胱刺激症:进行性加重or交替性缓解

(肾结核)(慢性肾盂肾炎-可有可无尿频尿急尿痛)

③抗生素是否有效　核心精讲·泌外感染和肿瘤

（性感认识：指征）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



肺结核患者反复咽下含结核杆菌的痰液致肠结核→蔓延致结核性腹膜炎→肾结核

肠结核蔓延、肺结核血源播散

一、肾结核 结核破坏慢

①多继发于肺结核，青壮年男性多见，病变多累及单侧 肾脏感觉神经在包膜,肾结核一般易侵犯到肾盂肾盏,很少累及包膜

对血管破坏比较温柔、慢

②**慢性膀胱刺激症**，血尿常在膀胱刺激症后出现（病变在肾、表现却在膀胱）VS急性膀胱炎:急性膀胱刺激征

③IVU/IVP：虫蚀样空洞、**肾盏肾盂变形**、**肾自截** 肾脏广泛钙化,输尿管因为狭窄闭掉,尿液流不到膀胱

静脉肾盂造影/静脉尿路造影　慢性病程,纤维收缩

④治疗：

肾盏无或很少破坏	抗结核
6-9 个月无效、肾盏破坏严重、或肾无功能	抗结核+患肾切除（术前抗结核＞2 周）防结核杆菌播散
患肾切除+抗结核 3-6 个月 待膀胱结核痊愈	输尿管皮肤造口术（若伴尿道狭窄）尿流改道 或乙状结肠膀胱扩大术（若伴膀胱挛缩且无尿道狭窄）

纤维收缩狭窄

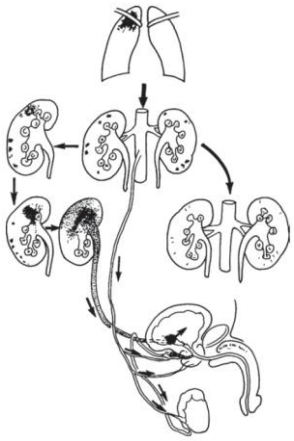


图 52-4　泌尿、男生殖系统结核的发病机制

肾结核→输尿管结核、膀胱结核

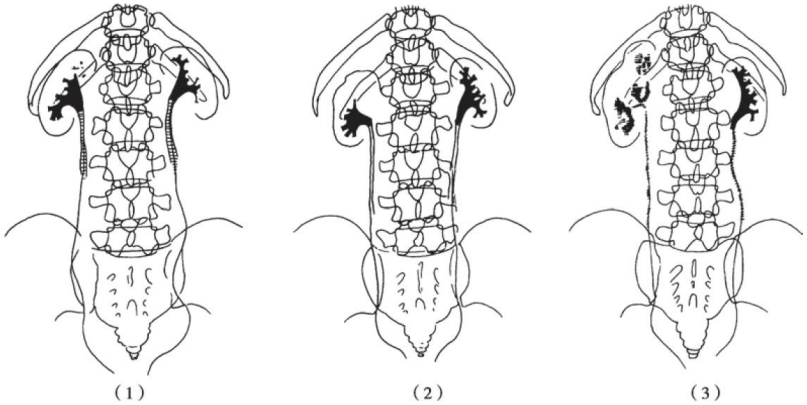


图 52-5　肾结核(逆行肾盂造影示意图)不能反映肾功能分肾功能

(1)右侧上肾盏破坏　(2)右侧上肾盏未充盈　(3)右侧肾和输尿管严重破坏



肾钙化

肾自截

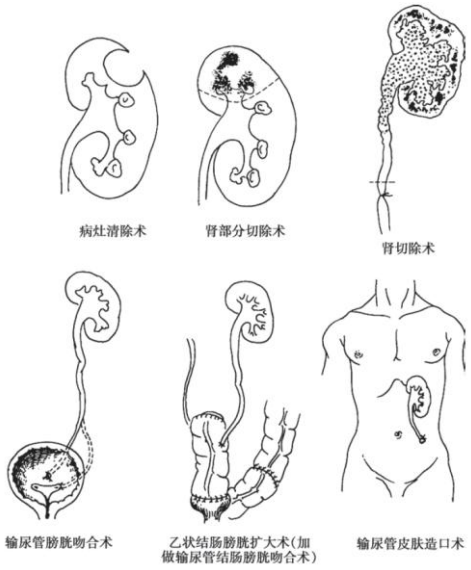


图 52-6　肾结核及其并发症的手术方法